

Tipo	PR	QRS	P:QRS	Urgência
1° Grau	>200ms fixo	Estreito	1:1	Baixa
Wenckebach	Prog. alonga	Estreito	N:N-1	Baixa-Mod
Mobitz II	Fixo normal	LARGO	N:N-1 fix	ALTA ■
BAV Total■nodal	Dissociado	Estreito	Dissoc.	ALTA
BAV Total■infra-His	Dissoc.	LARGO	Dissoc.	CRITICA !!

■ SINAIS DE INSTABILIDADE

- PAS < 90 mmHg (hipotensao)
 - Rebaixamento / síncope
 - Angina / dor toracica
 - Sinais de IC / EPA / baixo débito
- QUALQUER SINAL: MCC TRANSCUTANEO JA!

■ MOBITZ II — ATENCAO ABSOLUTA

- MP definitivo SEMPRE indicado
 - Mesmo se ASSINTOMATICO
- Atenção: BAVAS / Mobitz II são raras

DROGAS PONTE (MCC indisponível/falhou)

ATROPINA — DOSES E LIMITACOES

Parametro	Detalhe
Dose adulto	0,5 mg IV cada 3-5 min max 3 mg total
DOSE MINIMA	NAO usar < 0,5 mg → bradicardia paradoxal
Onset	Aumento de FC em 20-30 s

Droga	Dose	Uso
Dopamina	5-20 mcg/kg/min	Hipotensao+bradicardia
Adrenalina	2-10 mcg/min	BAVT + instabilidade grave
Glucagon	3-10 mg IV bolus	Intox BCC/Betabloq

MARCAPASSO TRANSCUTANEO (MCC) — PASSO A PASSO

POSICAO ANTEROPOSTERIOR (preferencial)

ANTERIOR (catodo/preto): V3-V4, esq do esterno
POSTERIOR (anodo/vermelho): infraescapular esq.

#	Acao
1	LIGAR aparelho selecionar modo PACE/PACER
2	MODO: Demand (sincronizado — padrao)
3	FREQUENCIA: iniciar 60-80 bpm
4	CORRENTE: iniciar 40-60 mA subir 10mA/vez
5	BUSCAR CAPTURA ELETRICA: espícula + QRS largo
6	CONFIRMAR CAPTURA MECANICA: PULSO palpavel

Parametro	Valor	Obs
Frequencia	60-80 bpm	Aumentar se hipotensao
Corrente adulto	40-80 mA	Iniciar 60 mA; subir 10mA
Corrente crianca	10-20 mA	Limiar geralmente < 40 mA

CAPTURA: ELETRICA vs MECANICA | COMPLICACOES FREQUENTES

Tipo	Achado / Conduta
Eletrica OK	Espícula + QRS largo apos cada estimulo
Mecanica OK	PULSO PALPAVEL sincronico (obrigatorio!)

Complicacao	Freq	Manejo
Dor/desconforto	>80%	Morfina 2-4mg IV + Midaz 1-2mg IV
Falha captura	~20%	Reposicionar; gel condutor

BAV NO IAM | FLUXOGRAMA DECISORIO RAPIDO

IAM	BAV	Prognostico	Conduta
IAM INFERIOR	BAV 1° / Wenckebach	Transitorio 2-3d	Atropina se sintom.
IAM INFERIOR	BAV Total nodal	Geralmente transit.	MCC; MVTT se>24h
IAM ANTERIOR	Mobitz II / BAV Total	Extenso; alta mort.	MVTT URGENTE
IAM ANTERIOR	BRD novo + BDF/BAS	Risco progressao	MVTT profilatico

- FC < 50 bpm com sintomas?
 - SIM INSTABILIDADE?
 - **SIM MCC TRANSCUTANEO IMEDIATO**
 - NAO Tipo de BAV?
 - 1°grau/Wenckebach Observar/tratar causa
 - Mobitz II / BAVT Atropina bridge + MVTT
 - Causa reversivel? Corrigir (K+/Ca2+/droga)

INDICACOES MP DEFINITIVO (ACC/AHA) | DICAS TEMI

Indicacao	Classe	NE
BAV 3° grau sintomatico	I	A
BAV 3° grau escape < 40 bpm	I	C
Mobitz II assintomatico	I	B
BAV 2:1 c/ QRS largo	I	B
BAV 3° transitorio pos-IAM anterior	I	B
BAV 1° PR>300ms sintomatico	Ila	C
BAV 1° assintomatico	III	B

- ★ Atropina minima adulto: 0,5 mg (< 0,5 = bradicardia paradoxal)
- ★ Captura mecanica obrigatoria — so eletrica nao basta
- ★ BAV 2:1 QRS estreito = Wenckebach provavel
- ★ BAV 2:1 QRS largo = Mobitz II ate prova em contrario
- ★ Isoproterenol: risco FV em IAM — usar com cautela
- ★ IAM inferior = BAV transitorio | Anterior = BAV permanente
- ★ Nó AV irrigado pela CD (85-90%) ou Cx (10-15%)
- ★ Glucagon: antídoto para intox por BCC e betabloq